

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	結腸造口灌洗 Colostomy Irrigation				
編號	A31000-Q05-W-B04	制定者	R12 吳育娟	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 07 月 23 日
版本/總頁數	第 3.5 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 16 日

一、目的

護理人員能正確操作結腸造口灌洗技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 清洗腸內糞便、驅氣及避免阻塞。
2. 養成定期排便的習慣以達到有效控制糞便，使其在適當時間排出（適用於永久性造口）。
3. 維護造口周圍皮膚之完整。

（二）用物準備

1. 人工肛門灌洗用具（全部自費）：
 - (1) 灌腸套 1 個。
 - (2) 錐狀灌洗頭 1 個。
 - (3) 拋棄式灌腸袋 1 個。
 - (4) 人工造口袋 1 個。
 - (5) 潤滑劑（Jelly 或 2% xylocaine）。
2. 清水或生理食鹽水(500～2000 c.c.)。
3. 點滴架 1 支。
4. 水溫計 1 支。

主題名稱	結腸造口灌洗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/6

5.衛生紙數張、濕紗或濕巾。

6.防水治巾各 1 條。

7.貼人工造口袋設備（剪刀、造口尺寸表、人工造口袋、人造皮、筆）1 套。

8.彎盆 1 個。

9.手套（丟棄式）1 付。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對醫囑及病人：	
(1)核對 HIS 護理系統／護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、使用頻率／核對狀態，核簽“正確”。	
(2)正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人或家屬解釋結腸造口灌洗目的及步驟。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日、無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2.工作前洗手。	
3.備齊所有用物於推車上。	
4.向病人解釋目的及過程。	
5.圍上屏風或拉上隔簾。	
6.將灌腸套中加入所需溶液量，測溫且排氣將錐狀灌洗頭連接妥當，掛於點滴架上。	溶液可為清水或生理食鹽水，溶液溫度為 37-38℃，灌腸套高度為液面至造口處 45-60 公分。
7.協助病人採側臥、半坐臥或坐姿。	姿勢視病人體力與舒適而定，以能看到護理人員操作為原則，若體力夠，可直接坐在馬桶上。
8.鋪防水治巾、於造口側下方，彎盆、於易取處。	
9.將病人衣服解開露出造口處。	
10.帶上手套，取下病人的人工造口袋，以濕紗或濕巾輕拭周圍，置污物於彎盆內。	觀察造口處有無紅腫、分泌物、內縮及壞死等現象。
11.為病人貼上拋棄式灌腸袋。	
12.於錐狀灌洗頭處塗上潤滑劑，並以食指沾潤滑劑伸入造口內約 5 公分，並擴張約 1 分鐘。	潤滑劑可使錐狀灌洗頭易於放入，食指深入主要為擴張造口處及確知方向。
13.將錐狀頭緩慢插入造口處約 5 公分，以手稍加壓固定，使錐狀頭盡量與造口處密合。	若不易插入，先使液體流入少量，再轉個方向或慢慢插入。
14.打開控制鈕，使溶液緩緩流入，時間約 5-10 分鐘，適量後關上控制鈕。	灌洗的水量依病人反應而定，最初 50 c.c.漸增至 500-800 c.c.。

主題名稱	結腸造口灌洗	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
	•灌洗時，觀察病人反應，若有疼痛厲害或灌入受阻，則暫停，可輕輕按摩病人腹部或教病人深呼吸，待症狀消失再調快速度。
15.灌完後，勿馬上移除錐狀灌洗頭，使其加壓3-5分鐘。	
16.移去錐狀頭，使排出液順著灌洗袋流至便盆或馬桶內。	
17.教導病人在腹部作順時鐘環狀按摩，以利液體排出，整個過程約30-60分鐘。	
18.完全排出後，移去灌洗袋。	
19.造口處以濕紗或濕巾輕拭乾淨，貼上人造皮保護墊，再黏上造口袋。	若糞便已成形，且能定期排便，則只需在造口上蓋上紗布。
20.脫手套，為病人整衣，協助採舒適的臥位。	
21.整理用物，若灌洗用具下次還要使用，則以清水洗淨、晾乾。	
22.工作後洗手。	
23.記錄：灌洗時間、溶液量、溫度、回流液性狀及量、造口周圍皮膚狀況、病人反應及接受指導情形。	

(四) 注意事項

- 1.在灌洗前，應先瞭解病人生活作息，與其討論灌洗的適合時間。
- 2.應仔細觀察造口之顏色、(正常為暗紅→紅色→粉紅)、形狀、位置是否有回縮或脫出的現象。造口周圍之皮膚性狀、造口分泌物及排泄物若有異狀應通知醫師。
- 3.水流太快或水溫太高、太低均可引起腹部不適，如發生腹部不適時可先暫停或深呼吸，等情況改善後再灌洗。
- 4.第一次灌洗約在手術後第一週開始(依醫囑而定)。
- 5.選擇適宜及一定的時間灌洗，當灌洗時發現病人人工肛門狹窄或流入的水不易流出時，需告知醫師。
- 6.病人健康狀態差，如癌症末期者不適於灌洗。
- 7.由護理人員執行灌洗時，應逐步教導病人及家屬正確的灌洗方法，以便病人能

主題名稱	結腸造口灌洗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/6

早日自行操作灌洗。

8.欲達到有效的控制糞便排出，同時還應配合飲食的調節。

9.施行結腸造瘻術的病人常有恐懼、害怕的心情及不安的情緒、生理功能改變及身體心像變化，易導致自卑的心理，因此尊重病人結腸灌洗期間的隱私，應安排隱密空間；護理人員執行灌洗時，避免露出嫌惡的表情，態度宜端莊、穩重，面帶微笑，逐步教導病人及家屬以免影響病人自尊。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王瑋(2000)•結腸造口灌洗，內外科護理技術(327-331 頁)•新北市：新文京。
- (二) 洪麗珍總校閱(2007)•結腸造瘻灌洗，內外科護理技術(191-204 頁)•台北：華杏。
- (三) 胡月娟總校閱(2013)•結腸造瘻灌洗，內外科護理技術(757-759 頁)•台北：華杏。
- (四) 于博芮、胡文郁、胡月娟、周守民、吳韻淑、羅筱芬...李惠玲(2013)·結腸造口灌洗·成人內外科護理(178-182 頁)·台北市:華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	結腸造口灌洗	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B04	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.06.06	2.1	刪除用物準備：(1)繫腰帶 1 條(2)環狀扣 1 個（可以拋棄式灌腸袋取代）(3)長型灌洗袋 1 個（可以拋棄式灌腸袋取代）。 與內容修辭	101 年 06 月 06 日 護理部技術標準 委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.17	3.1	說明內容部份修辭潤飾。	103 年 06 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過。
104.06.18	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.06.21	3.3	修正第三項第(三)目之 1(2)病人辨識說明。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.06.19	3.4	新增第六項參考資料。	
107.06.25	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.17	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日 護理技術組會議 通過；108 年 07 月 17 日護理長會 議通過；108 年 07 月 23 日督導會議 通過公布。
109.06.15	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

